Transferencias y Marcha Segura

Guía de movilización, auxiliares de marcha y prevención de caídas

1. Principios Generales de Seguridad

- Evalúa la capacidad funcional del paciente antes de cada transferencia.
- Explica claramente cada paso al paciente antes de ejecutarlo.
- Asegura el entorno: frenos de silla/cama, piso seco, espacio libre.
- Usa mecánica corporal correcta: flexiona rodillas, mantén la carga cerca del cuerpo.
- Nunca tires del paciente por las extremidades; guía desde el tronco o la pelvis.
- Si el paciente no puede colaborar activamente, solicita ayuda de un segundo asistente.
- Ten el calzado antiderrapante del paciente puesto antes de iniciar.

2. Transferencias Básicas

Cama a silla de ruedas

1. Coloca la silla de ruedas en ángulo de 30–45° respecto a la cama, del lado fuerte del paciente.

2. Pon los frenos de la silla y retira los descansapiés.

3. Ayuda al paciente a sentarse al borde de la cama con los pies en el piso.

4. El paciente se impulsa con los brazos; el fisioterapeuta guía desde la cintura o el cinturón de transferencia.

5. Pivotea sobre el pie del lado fuerte hasta quedar frente a la silla.

6. El paciente desciende controladamente hacia el asiento de la silla.

Silla a bipedestación

1. El paciente se desplaza hacia el borde anterior del asiento.

2. Coloca los pies del paciente ligeramente por detrás de las rodillas.

3. El paciente inclina el tronco hacia adelante ('nariz sobre los dedos de los pies').

4. Se impulsa con las manos en los apoyabrazos o en las rodillas.

5. Extiende rodillas y caderas simultáneamente hasta la posición erguida.

6. El fisioterapeuta estabiliza desde la pelvis o el cinturón de transferencia.

Piso a bipedestación (tras una caída)

1. Evalúa posibles lesiones antes de intentar levantar al paciente.

2. Si no hay lesión, el paciente se gira hacia decúbito prono.

3. Avanza a posición de gateo (cuatro puntos).

4. Se acerca a un mueble estable (silla, mesa) y coloca las manos sobre él.

5. Lleva un pie al frente (posición de caballero) y se impulsa hacia arriba.

6. El fisioterapeuta asiste desde la pelvis sin cargar el peso completo.

3. Auxiliares de Marcha

Auxiliar	Tipo	Indicación	Consideraciones clave
Bastón	Estándar, con empuñadura en T o en J	Inestabilidad leve, descarga parcial, claudicación	Se usa **contralateral** al lado afectado. Altura: trocánter mayor o pliegue de la muñeca.
Andador	Estándar (fijo), con ruedas frontales, rollator (4 ruedas con freno)	Mayor inestabilidad, debilidad bilateral, adultos mayores con riesgo de caídas	El estándar da más estabilidad; el rollator permite marcha más fluida. Altura: trocánter mayor.
Muletas axilares	Par de muletas axilares	Descarga total o parcial de un miembro inferior, fracturas, postquirúrgico	El apoyo es en las manos, **no en la axila**. Riesgo de lesión de plexo braquial si se apoyan mal.
Muletas de codo	Canadienses / Lofstrand	Uso prolongado, patologías crónicas, descarga permanente	Mayor independencia funcional que las axilares. Requieren fuerza en miembros superiores.

4. Patrones de Marcha con Auxiliares

Patrón	Secuencia	Indicación
Marcha en 2 tiempos	Muleta derecha + pie izquierdo → muleta izquierda + pie derecho (simultáneo)	Carga parcial bilateral, buena coordinación
Marcha en 3 tiempos	Ambas muletas → pie afectado → pie sano	Descarga del miembro afectado, carga parcial permitida
Marcha en 4 tiempos	Muleta derecha → pie izquierdo → muleta izquierda → pie derecho	Máxima estabilidad, pacientes con debilidad bilateral, mayor lentitud
Marcha pendular	Ambas muletas → balanceo del cuerpo hasta o más allá de las muletas	Pacientes con paraplejía que usan órtesis, descarga total de miembros inferiores

5. Prevención de Caídas

Ámbito	Estrategia
Evaluación del riesgo	Aplicar escalas como Tinetti o Berg. Identificar factores de riesgo: medicamentos, déficit visual, calzado inadecuado, historia de caídas.
Modificaciones del entorno	Iluminación adecuada, barras de apoyo en baño, retiro de tapetes sueltos, pisos antiderrapantes, mobiliario estable.
Ejercicios de equilibrio	Apoyo unipodal, marcha en tándem, ejercicios con desestabilización controlada, Tai Chi adaptado.
Fortalecimiento	Énfasis en cuádriceps, glúteos, dorsiflexores de tobillo. Sentadillas asistidas, subir escalones.
Educación al paciente	Uso correcto del auxiliar de marcha, levantarse despacio, solicitar ayuda cuando sea necesario, revisar medicamentos con el médico.

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.